Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Врач-оториноларинголог, специалист по хирургии головы и шеи

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

Тонзиллэктомия

Удаление нёбных миндалин (полное или частичное)

Уважаемый пациент, эта форма составлена для того, чтобы **простым и понятным языком** рассказать вам о том, что необходимо знать о рекомендованной вам процедуре. Её цель — не напугать вас, а помочь вам принять решение **свободно и на основе достоверной информации**.

Пожалуйста, прочитайте эту форму не торопясь. Обо всём, что вам непонятно, спросите своего врача. Врач также устно объяснит вам риски, связанные именно с вашим состоянием. Давать или не давать согласие — исключительно ваше право.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ И ПРОЦЕДУРЕ

Фамилия, имя: _____ Дата рождения: _____

№ паспорта / удостоверения личности: _____ № карты / протокола: _____

Телефон: _____ Дата информирования: _____

Планируемая дата процедуры: _____

Форма впервые передана пациенту (дата / эл. почта, WhatsApp, лично): _____

Врач, который выполняет процедуру и предоставляет информацию: **Op. Dr. Murat Ayata**

Больница / медицинское учреждение, где будет выполнена процедура: _____

Планируемая техника:
- ☐ Холодная (инструментальная) диссекция
- ☐ Диатермия (электрокоагуляция)
- ☐ Радиочастотная техника / коблация
- ☐ Тонзиллотомия (частичное удаление)

Дополнительные процедуры в ту же сессию: ☐ Аденоидэктомия ☐ Вентиляционная(-ые) трубка(-и) ☐ Нет _____

Показание к операции (заполняет врач):
- ☐ Рецидивирующий тонзиллит
- ☐ Нарушения дыхания во сне / храп ☐ Паратонзиллярный абсцесс
- ☐ Одностороннее увеличение / гистологическая диагностика

_____

Другое / примечания: _____

1 Ваше состояние и цель процедуры

Нёбные миндалины (гланды) — это лимфоидная ткань, часть иммунной системы организма, расположенная по обеим сторонам глотки над корнем языка. После удаления миндалин иммунная система продолжает работать за счёт других лимфоидных тканей рта и глотки; не доказано, что операция ослабляет иммунитет.

Тонзиллэктомию чаще всего рекомендуют при: **тонзиллите (ангине)**, который повторяется несколько раз в год и приводит к пропускам школы или работы; увеличенных миндалинах, вызывающих **храп и остановки**

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

дыхания во сне; **абсцессе вокруг миндалины (паратонзиллярном абсцессе)**; одностороннем увеличении миндалины или подозрительном изменении ткани. У некоторых пациентов причинами также могут быть неприятный запах изо рта и миндальные камни (тонзиллолиты).

Цель операции — устранить или уменьшить эти проблемы. Врач отдельно объяснит, почему операция рекомендована вам или вашему ребёнку.

2 Как выполняется процедура?

Операция проводится под общей анестезией в операционной, через рот; **снаружи нет никаких разрезов или рубцов.**

1. **Подготовка:** После введения анестезии устанавливают специальный инструмент, который удерживает рот открытым и защищает язык.
2. **Удаление миндалин:** Каждую миндалину вместе с окружающей её капсулой отделяют от расположенного под ней мышечного слоя и удаляют. В зависимости от планируемой техники это делают ножницами и инструментами для диссекции (холодная диссекция), электрокоагулятором или радиочастотными/коблационными аппаратами.
3. **Частичное удаление (тонзиллотомия):** У подходящих пациентов, особенно у маленьких детей с нарушениями дыхания во сне, может удаляться только увеличенная часть миндалины с сохранением тонкого слоя ткани. Этот метод может вызывать меньше боли и сопровождаться меньшим риском кровотечения; однако оставшаяся ткань может снова разрастись или воспалиться.
4. **Остановка кровотечения:** Любое кровотечение в ложах миндалин тщательно останавливают с помощью швов, перевязки или коагуляции. Ложа миндалин обычно оставляют открытыми, и они заживают самостоятельно.
5. **Дополнительные процедуры:** Если это запланировано, под той же анестезией выполняют удаление аденоидов (аденоидэктомию) или установку вентиляционных трубок (шунтов); для этих процедур заполняются отдельные формы согласия.
6. **Пробуждение и наблюдение:** После операции пациента наблюдают в палате пробуждения, а затем в отделении — контролируют кровотечение, дыхание и приём жидкости.

Если врач сочтёт это необходимым, удалённые миндалины направляют на патоморфологическое (гистологическое) исследование.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ / ВЫПИСКА
Общая анестезия	Около 30–45 минут (без учёта времени анестезии)	Обычно одна ночь в больнице под наблюдением

3 Ожидаемая польза и вероятность успеха

- Значительное уменьшение частоты рецидивирующего тонзиллита и связанных с ним повышения температуры, боли в горле, приёма антибиотиков и пропусков школы или работы
- Меньше храпа и остановок дыхания во сне; более качественный сон, улучшение внимания и поведения в течение дня
- Предотвращение повторных паратонзиллярных абсцессов
- При необходимости — постановка точного диагноза благодаря патоморфологическому исследованию ткани

У тщательно отобранных пациентов рецидивирующие инфекции горла и нарушения дыхания во сне в значительной степени проходят. После операции инфекции горла (фарингит) всё же могут иногда возникать, но, как правило, реже и в более лёгкой форме. Если у апноэ сна есть и другие причины — например, избыточный вес, строение лица или заложенность носа, — симптомы могут пройти не полностью и может потребоваться дополнительное лечение.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

4 Другие варианты лечения

- **Наблюдение:** Если частота инфекций не соответствует критериям для операции или симптомы выражены слабо, может быть целесообразно подождать, регулярно проходя осмотры. У детей тонзиллит с возрастом может возникать реже.
- **Антибиотики и поддерживающее лечение:** Каждый эпизод инфекции продолжают лечить лекарствами; это не предотвращает новые эпизоды.
- **Частичное удаление (тонзиллотомия):** У подходящих пациентов может рассматриваться вместо полного удаления (описано выше).
- **Другие варианты при апноэ сна:** Снижение веса, лечение заложенности носа, назальные спреи с кортикостероидами или аппарат для создания постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP) во время сна.

5 Что будет, если процедуру не проводить?

Без операции могут сохраняться рецидивирующий тонзиллит, повышение температуры, приём антибиотиков и пропуски школы или работы. В редких случаях вокруг миндалины может образоваться абсцесс или инфекция может распространиться на ткани шеи. Если апноэ сна, вызванное увеличенными миндалинами, не лечить, оно может — особенно у детей — приводить к замедлению роста и развития, проблемам с вниманием и поведением, ночному недержанию мочи, а в долгосрочной перспективе — к нагрузке на сердце и лёгкие. В подозрительных ситуациях, например при одностороннем увеличении, отказ от операции может задержать постановку точного диагноза.

Вы имеете право отказаться от рекомендованной процедуры, отложить её или получить мнение другого врача. Это решение никак не повлияет на любую другую медицинскую помощь, которая вам предоставляется. Вы можете отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры; однако, пожалуйста, имейте в виду, что после начала процедуры могут быть этапы, на которых её прекращение небезопасно с медицинской точки зрения.

6 Подготовка к процедуре

- Перед операцией проводятся анализы крови (особенно на свёртываемость) и другие необходимые обследования; вас также осмотрит врач-анестезиолог.
- Пожалуйста, обязательно сообщите нам, если у вас или у кого-либо в вашей семье есть склонность к повышенной кровоточивости, частые носовые кровотечения, длительные менструальные кровотечения, кровотечение, которое не останавливалось после удаления зуба, или известное нарушение свёртываемости крови.
- В течение **6 часов** до операции нельзя принимать твёрдую пищу и молоко; в отношении прозрачных жидкостей соблюдайте время, указанное анестезиологом.
- Пожалуйста, сообщите нам, если в течение 2–3 недель до операции был активный тонзиллит, заболевание с повышением температуры или грипп; операцию, возможно, придётся отложить.
- Сообщите врачу о шатающихся зубах или зубных протезах.
- Если вы приезжаете из-за рубежа, мы рекомендуем после операции **не менее 10–14 дней** оставаться там, откуда можно быстро связаться с врачом и добраться до больницы (из-за риска позднего кровотечения).
- Сообщите врачу обо **всех лекарствах**, которые вы принимаете (включая препараты, разжижающие кровь, аспирин, обезболивающие, средства для похудения и гормональные препараты), а также о любых **растительных средствах и добавках** (например, омега-3, витамин E, гинкго, чеснок, женьшень, рыбий жир). Не прекращайте приём какого-либо лекарства самостоятельно, без согласования с врачом.
- Обязательно сообщите нам об **аллергиях**, проблемах с кровотечением или свёртываемостью крови, заболеваниях сердца и лёгких, диабете, нарушениях артериального давления или щитовидной железы, перенесённых операциях и любых проблемах, которые возникали у вас при анестезии.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Если есть вероятность, что вы беременны, или если вы кормите грудью, обязательно сообщите нам об этом до процедуры.
- Курение и никотиносодержащие продукты значительно ухудшают заживление ран. По возможности откажитесь от них как минимум за 2–4 недели до процедуры и не курите в период восстановления.

7 Восстановление: чего ожидать

День операции	После пробуждения у вас будет болеть горло; боль снимают обезболивающими. Когда тошнота проходит, дают воду, затем прохладные или тёплые напитки и мягкую пищу. Вы останетесь в больнице на ночь под наблюдением в отношении кровотечения, дыхания и приёма жидкости.
1–4-й день	Боль в горле и боль, отдающая в уши, выражены заметно. На ложах миндалин образуется **бело-желтоватый налёт**; это нормальная часть заживления, а не инфекция. Возможны неприятный запах изо рта и небольшое повышение температуры. Самое важное — **регулярно принимать обезболивающие и пить много жидкости**.
5–10-й день	Белый налёт начинает отходить. В этот период боль иногда может снова усиливаться. **Именно в это время риск позднего кровотечения наиболее высок**; избегайте интенсивных физических нагрузок, горячих ванн/саун и твёрдой пищи и при любых признаках кровотечения немедленно обращайтесь за помощью.
10–14-й день	Боль заметно уменьшается, и можно вернуться к обычному питанию. Большинство детей возвращаются в школу, а взрослые — на работу в течение 10–14 дней. Спорт и тяжёлые физические нагрузки, как правило, разрешаются примерно через 2–3 недели.
3–6-я недели	Ложа миндалин полностью заживают. Проводится контрольный осмотр; если проводилось патоморфологическое исследование, обсуждается его результат.

8 Возможные риски и осложнения

Как и любая медицинская процедура, эта процедура сопряжена с определёнными рисками. Ниже **ожидаемые временные эффекты** и **осложнения** приведены отдельно и сгруппированы по частоте их возникновения. Приведённые цифры — **приблизительные** значения, основанные на данных медицинской литературы; ваш личный риск может быть ниже или выше в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, курения и перенесённых операций.

Подавляющее большинство осложнений **временные** и проходят при надлежащем лечении. В список включены и очень редкие, но серьёзные события; то, что они упомянуты, не означает, что они произойдут с вами, однако вам необходимо знать о них, чтобы принять осознанное решение.

Ожидаемые временные эффекты (не являются осложнениями — это естественная часть заживления)

- Боль в горле (обычно длится 7–14 дней; у взрослых выражена сильнее, чем у детей)
- Боль, отдающая в уши (отражённая боль; она не означает, что в ухе есть проблема)
- Затруднённое глотание и снижение аппетита; некоторая потеря веса в первые дни
- Бело-жёлтый налёт заживления на ложах миндалин и неприятный запах изо рта
- Небольшое повышение температуры (в первые дни), тошнота и рвота из-за анестезии
- Временный отёк языка и нёбного язычка (увулы)

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Частые состояния (большинство из них временные или проходят при лечении)

- **Кровотечение после операции (позднее кровотечение)** — Возникает примерно у **2–5 из 100** пациентов, чаще всего **через 5–10 дней после операции**, когда отходит налёт заживления. У взрослых встречается несколько чаще, чем у детей. Большинство кровотечений незначительны и прекращаются при наблюдении, прикладывании льда, лечении в полости рта или простом вмешательстве.
- **Повторная операция из-за кровотечения** — Примерно у **1–3 из 100** пациентов для остановки кровотечения может потребоваться **повторное вмешательство в операционной под общей анестезией**. Пребывание в больнице может продлиться.
- **Недостаточный приём жидкости и обезвоживание** — Если из-за боли выпивается недостаточно жидкости, может появиться слабость и уменьшиться количество мочи, особенно у маленьких детей; иногда требуется госпитализация для внутривенного введения жидкости.

Нечастые состояния

- **Переливание крови** — Если при кровотечении теряется много крови, может потребоваться переливание крови; это происходит **значительно реже чем у 1 из 100** пациентов.
- **Нарушение вкуса и онемение языка** — Поскольку во время операции язык прижат инструментом, возможны изменение вкуса или онемение языка; обычно это проходит в течение нескольких недель, но в редких случаях может длиться месяцами или остаться навсегда.
- **Травма зубов, губ и языка** — Давление инструмента, удерживающего рот открытым, может привести к отколу зуба (особенно шатающегося или поражённого кариесом) или вызвать небольшой ожог, ранку или отёк на губах или языке.
- **Инфекция** — Инфекция может развиться в ложах миндалин или в области шеи; обычно её лечат антибиотиками.
- **Временная гнусавость голоса** — Поскольку из-за боли подвижность нёба ограничена, при разговоре воздух может временно выходить через нос; обычно это проходит в течение нескольких недель.
- **Повторное разрастание после тонзиллотомии** — Если выполнялось частичное удаление, оставшаяся ткань миндалины может снова разрастись или воспалиться (примерно у **1–6 из 100**); в редких случаях затем может потребоваться полная тонзиллэктомия.

Редкие или очень редкие, но потенциально серьёзные состояния

- **Тяжёлое кровотечение и его последствия** — В редких случаях кровотечение может быть сильным и быстрым. Тогда могут потребоваться **экстренная операция, переливание крови** и, очень редко, дополнительные вмешательства на кровеносных сосудах шеи. Большая кровопотеря или попадание крови в дыхательные пути могут привести к серьёзным последствиям, таким как **дыхательная недостаточность, необходимость лечения в отделении интенсивной терапии** и связанный с этим стойкий вред здоровью.
- **Угрожающие жизни осложнения и смерть** — Смерть, связанная с тонзиллэктомией, встречается крайне редко; в медицинской литературе она описывается примерно в **1 случае на 15 000–35 000 операций**. Наиболее частые причины — тяжёлое кровотечение и проблемы с дыханием. У маленьких детей с тяжёлым апноэ сна риск проблем с дыханием после операции выше, поэтому за такими пациентами наблюдают более пристально.
- **Стойкая гнусавость / попадание жидкости обратно в нос (велофарингеальная недостаточность)** — Встречается очень редко; в основном у людей со скрытой расщелиной нёба. Могут потребоваться занятия с логопедом или, в редких случаях, корригирующая операция.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Смещение шейных позвонков (синдром Гризеля), распространение инфекции на шею или грудную полость** — Очень редкие состояния, которые поддаются лечению при раннем выявлении. Они могут проявляться постепенно усиливающейся болью в шее, невозможностью повернуть голову, высокой температурой и невозможностью глотать. При их развитии необходимы госпитализация, внутривенное введение антибиотиков и при необходимости хирургическое дренирование; при задержке лечения могут развиться стойкие проблемы с шеей, а распространяющаяся инфекция может стать угрожающей жизни.
- **Рубцевание и сужение глотки и нёба** — Очень редко во время заживления может образоваться избыточная рубцовая ткань, которая сужает глотку или нёбо и вызывает затруднения при глотании или речи.
- **Боль или вывих в височно-нижнечелюстном суставе** — Очень редко возникает из-за того, что рот долгое время удерживается открытым.

Общие риски, относящиеся к любому хирургическому / медицинскому вмешательству

- **Риски анестезии:** Если применяется общая анестезия или седация, её риски (тошнота, боль в горле, повреждение зубов, аллергическая реакция и, очень редко, проблемы с сердцем или лёгкими) отдельно разъяснит врач-анестезиолог, и ваше согласие будет получено на **отдельной форме согласия на анестезию**.
- **Кровотечение и переливание крови:** Необходимость переливания крови при этих процедурах возникает очень редко. При серьёзном кровотечении может потребоваться введение крови или препаратов крови; это также связано с собственными очень редкими рисками (например, аллергией или инфекцией).
- **Инфекция:** Раневую инфекцию после операции обычно лечат антибиотиками; в редких случаях может потребоваться дренирование (удаление гноя).
- **Тромбы в венах ног (ТГВ) и в лёгких (тромбоэмболия лёгочной артерии):** При непродолжительных операциях на голове и шее встречаются очень редко. Ранняя двигательная активность снижает риск. Приём гормональных препаратов, курение, ожирение и тромбозы в прошлом повышают риск.
- **Лекарственная аллергия:** Может развиться аллергическая реакция на используемые лекарства, антисептики, пластыри или шовный материал.
- **Рубцы и проблемы с заживлением:** Формирование рубцов у разных людей происходит по-разному; очень редко может образоваться грубый (гипертрофический) рубец или келоид.
- **Риск для жизни:** В наши дни смерть при плановых операциях на голове и шее встречается крайне редко; однако ни одно хирургическое вмешательство не является полностью безрисковым. При серьёзном осложнении может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии и может наступить стойкая инвалидность.

Этот список не охватывает все возможные осложнения; могут возникнуть и другие непредсказуемые и очень редкие события. Если разовьётся осложнение, врач спланирует необходимое лечение и наблюдение; это может потребовать дополнительного лечения, лекарств, процедур или повторной операции.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Когда нужно немедленно связаться с нами

- **Свежая, ярко-красная кровь** изо рта, сплёвывание крови или рвота кровью — **даже несколько капель** — без промедления обращайтесь за помощью. При кровотечении наклоните голову вперёд и сплёвывайте кровь, не проглатывая её; можно полоскать горло холодной водой.
- У детей: **частое глотание**, бледность, слабость, трудное пробуждение (может быть признаком проглоченной крови)
- **Затруднённое дыхание**, выраженные остановки дыхания во сне, шумное дыхание
- **Температура выше 38,5 °C** или боль, которая не проходит после приёма обезболивающих или продолжает усиливаться
- Полный отказ от питья, отсутствие мочеиспускания в течение 8 часов, необычная сонливость (признаки обезвоживания)
- Постепенно усиливающаяся боль в шее, невозможность повернуть голову, отёк шеи

Если возникнет что-либо из перечисленного, немедленно позвоните своему врачу: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Если вы не можете с нами связаться, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните по номеру 112.

10 Рекомендации по лекарствам и повседневной жизни

- Для обезболивания используйте только **обезболивающие, рекомендованные врачом**, в рекомендованной дозе и с рекомендованными интервалами, и **принимайте их регулярно**. Аспирин и другие обезболивающие, не рекомендованные врачом, могут повышать риск кровотечения; не добавляйте никаких лекарств самостоятельно.
- **Обильное питьё** — самое важное правило. Подходят прохладная или тёплая вода, айран (кисломолочный напиток), компот, мороженое, молочный пудинг, йогурт и пюре. Примерно **2 недели** избегайте очень горячей, кислой, острой и твёрдой/хрустящей пищи (чипсы, крекеры, тосты).
- В первые 2 недели избегайте интенсивных физических нагрузок, горячих ванн, саун и длительного пребывания на солнце.
- Чистить зубы можно и дальше; избегайте любого грубого контакта с областью горла.
- Рекомендуем отложить обратный перелёт за рубеж до тех пор, пока не минует риск позднего кровотечения (обычно **10–14 дней после операции**). Если вам необходимо улететь раньше, обсудите риски с врачом.
- Принимайте назначенные вам лекарства (антибиотики, обезболивающие и т. д.) в рекомендованной дозе и в течение рекомендованного срока. Не принимайте аспирин или подобные ему лекарства, которые могут усиливать кровоточивость, не посоветовавшись с врачом.
- Во время перелётов или поездок продолжительностью более 4 часов после операции пейте много воды, регулярно двигайтесь и, если вам это рекомендовано, носите компрессионные чулки; это снижает риск образования тромбов в ногах.
- В период восстановления рекомендуется не употреблять алкоголь, а также воздерживаться от курения и никотиносодержащих продуктов.
- Пожалуйста, обязательно приходите на все контрольные осмотры. Если вы приехали из-за рубежа, после возвращения домой наблюдение может продолжаться в формате онлайн-консультаций и по фото/видео; если вам понадобится обратиться к местному врачу, вам будут выданы письменный протокол операции и наши рекомендации.

11 Непредвиденные ситуации во время процедуры, образцы тканей и препараты крови

Если во время процедуры возникнет непредвиденная ситуация, врач останется в рамках той процедуры, на которую вы дали согласие в этой форме. **Если нет угрозы для жизни или риска серьёзного вреда для органа**, никакое дополнительное вмешательство, на которое вы не давали согласия, выполняться не будет; в таком случае процедура будет завершена в безопасный момент, а затем вас проинформируют, чтобы решение было

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

принято вместе с вами. Если же ваша жизнь в опасности, будет оказана неотложная помощь, необходимая для сохранения вашей жизни или органа.

Удалённые во время процедуры ткани при необходимости направляются на **патоморфологическое (гистологическое) исследование** для уточнения диагноза. В зависимости от результата может потребоваться дополнительное лечение или наблюдение.

Переливание крови при этих процедурах требуется очень редко и проводится только по жизненным показаниям. Если вы не согласны на введение крови или препаратов крови (например, по религиозным убеждениям), обязательно сообщите об этом до процедуры; возможные последствия такого решения будут отдельно обсуждены с вами и записаны в разделе «Информация, касающаяся лично вас».

12 Фотографии, видеозаписи и ваши персональные данные

До и после процедуры могут быть сделаны **фотографии/видеозаписи** для планирования, наблюдения и оценки результата. Эти материалы являются частью вашей медицинской документации и хранятся конфиденциально. Ваши изображения **ни при каких обстоятельствах не будут использоваться для рекламы, продвижения или в социальных сетях.**

Использование ваших изображений для любых других целей возможно **только с вашего отдельного и явно выраженного разрешения**. Отказ никак не повлияет на ваше лечение, и вы можете отозвать своё разрешение в любое время:

- ☐ Я согласен(-на) на использование моих изображений **только для медицинской документации и наблюдения за лечением**.
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, чтобы меня нельзя было узнать** (с закрытой областью лица/глаз).
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, что меня можно будет узнать**.
- ☐ Я **не разрешаю** использование в научных/образовательных целях.

Ваши персональные данные и данные о здоровье обрабатываются в соответствии с турецким Законом о защите персональных данных № 6698 (KVKK) и соответствующим законодательством в сфере здравоохранения в целях диагностики, лечения и исполнения требований закона лицами, связанными обязательством сохранения профессиональной тайны. Подробную информацию вы найдёте в нашем Уведомлении о защите персональных данных.

13 Информация и примечания, касающиеся лично вас (заполняет врач)

Дополнительные риски, касающиеся данного пациента (сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, перенесённые операции), подробности плана, ожидания пациента, заданные вопросы и полученные ответы. Если добавить нечего, пишется «нет».

14 Заявление пациента

- ☐ Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму на своём языке. Мне было предоставлено достаточно времени для размышления; у меня была возможность задать вопросы, и я получил(-а) удовлетворившие меня ответы.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Мне устно и письменно разъяснили моё состояние, цель рекомендованной процедуры, как, кем и где она будет выполнена, её примерную продолжительность, ожидаемую пользу, вероятность успеха, альтернативы и то, что может произойти, если её не проводить.
- ☐ Мне разъяснили частые и потенциально серьёзные риски, а также возможные последствия этих осложнений (в том числе то, что может потребоваться дополнительное лечение или повторная процедура/операция). Я понимаю, что результат любой медицинской процедуры **не может быть гарантирован на 100%**.
- ☐ Я предоставил(-а) точную и полную информацию о своём здоровье, принимаемых лекарствах, аллергиях и перенесённых заболеваниях. Я понимаю, что неполная или неверная информация может увеличить риски.
- ☐ Я понимаю, что соблюдение указаний, данных до и после процедуры, влияет на результат и что посещение контрольных осмотров важно.
- ☐ Я знаю, что могу отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры. Я понимаю, что подписание этой формы не освобождает врача от обязанности проявлять должную заботу и тщательность.
- ☐ Я принимаю это решение по собственной воле, без давления с чьей-либо стороны.
- ☐ Мне ясно разъяснили, что в течение первых 2 недель после операции, особенно на 5–10-й день, **может возникнуть позднее кровотечение**; что в этом случае я должен(-на) без промедления связаться с врачом или обратиться в ближайшее отделение неотложной помощи; и что кровотечение может потребовать повторной операции, переливания крови и, в редких случаях, лечения в отделении интенсивной терапии.

- ☐ **Я ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на описанную выше процедуру.**
- ☐ **Я НЕ СОГЛАСЕН(-НА) на описанную выше процедуру. Мне разъяснили возможные последствия отказа.**

Рекомендуется, чтобы пациент написал собственноручно: «Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму и даю своё согласие».

---

15 Подписи

	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА / ВРЕМЯ
Пациент			
Законный представитель (родитель / опекун) — отношение к пациенту:			
Врач, предоставляющий информацию и выполняющий процедуру			
Переводчик (при необходимости) — язык:			
Свидетель (при необходимости)			

Заявление переводчика: я полностью и точно перевёл(-а) эту форму и устные разъяснения врача пациенту / законному представителю на понятный ему язык.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

За пациентов младше 18 лет согласие дают **родитель или законный опекун**. Ребёнка информируют в соответствии с его возрастом и зрелостью и учитывают его мнение. За недееспособных пациентов согласие даёт законный представитель.

☐ Если мы осуществляем родительские права совместно, я заявляю, что второй родитель осведомлён об этой процедуре и согласен с ней.

☐ Я заявляю, что не существует судебного решения или спора относительно опеки / попечительства (если они есть, соответствующий документ был предъявлен врачу).

Ребёнок проинформирован в соответствии с его возрастом; мнение ребёнка: _____

Эта форма составлена в двух экземплярах: один хранится в медицинской карте пациента, другой выдаётся пациенту / законному представителю.

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ)

Я отзываю согласие, которое дал(-а) выше. Мне разъяснили возможные последствия отзыва согласия.

Ф. И. пациента/представителя, отзывающего согласие, подпись, дата и время: _____

Эта форма составлена в соответствии с Положением о правах пациентов Турецкой Республики и принципами информированного согласия Турецкой медицинской ассоциации. Она дополняет, но не заменяет устные разъяснения вашего врача.